

TEMA 4.19 • DERMATOLOGÍA

Enfermedades Autoinmunes con Imágenes

PERFIL EUNACOM 6.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Dermatosis Nodulares y Úlceras de Trasfondo Autoinmune Sistémico

Un selecto grupo de afecciones dermatológicas asoman no como enfermedad primaria aislada, sino como marcadores externos o comorbilidades patognomónicas entrelazadas con graves enfermedades sistémicas inflamatorias intestinales, infecciones granulomatosas profundas o intolerancias gástricas genéticas.

1. Eritema Nodoso (Paniculitis Primaria)

- **Fisiopatología Analítica:** Corresponde a una severa inflamación del tejido graso celular subcutáneo (Paniculitis). - **Las Causas Universales EUNACOM:** Su etiología N°1 en frecuencia clínica general **NO es autoinmune de entrada, sino que obedece a etiología Post-Infecciosa** reactiva (Infecciones estreptocócicas altas u otras bacterias previas tempranas). En segundo lugar es la cruza Reacción Adversa a Medicamentos; y en tercer lugar asedia como el clásico cruce patognomónico estricto autoinmunitario colateral: **Reactivo paralelo atado grave a la Enfermedad de Crohn (Inflamatoria Intestinal), a la Espondilitis Anquilosante cruzada grave espinal, y a la Sarcoidosis granulomatosa basal pulmonar.** - **Cuadro Clínico Diferencial Perimetral Oro:** Aparición de cuerosos **Nódulos eritematosos inmensamente Dolorosos focales al palpar.** - **Cartografía Obligada Focal Geográfica Excluyente:** Focaliza férrea y anatómicamente con predilección altísima casi que excluyente en **LA CARA ANTERIOR (Pretibial Estirada frontal) DE AMBAS PIERNAS.** - **Tratamiento Focal Base:** Manejo pasivo apaciguador del dolor inflamatorio por pilastras cruzadas crudas con los **Antiinflamatorios AINEs.** En refractariedad o rebote crónico severo se escala a yoduro de potasio o al corticoide oral general de frenado cruzado.

2. Pioderma Gangrenoso (Úlcera Falsa-Infecciosa Grave)

- **Acierto Patognomónico Extremo Invasivo:** Arranca silente con una sencilla pápula o costra pero evoluciona estallando fulminantemente rápida destruyendo cruzado en masa el tejido graso subyacente. Acaba en pocos días transformándose abrupto en una inmensa **Úlcera de bordes inflamatorios rojos violáceos de cráter cruzado socavado purulento dantesco, asimilando ser la herida infecciosa basal de la peor cruza purulenta bacteriana letal.** - **La Trampa EUNACOM:** Pese al nombre ("Pio"derma) ¡NO ES PARA NADA BACTERIANO O INFECCIOSO!. Es un cuadro enteramente genético autoinmunitario inflamatorio general (Y responde letal empeorando en general al bisturí por patrón de patergia reaccionaria de corte). - **Asociaciones Sistémicas de Alerta Basal:** Obliga a cruzar la indagación de la anamnesis por: **Enfermedades autoinmunes intestinales como Colitis Ulcerosa/Crohn, Artritis Reumatoide o los letales Cánceres Hematológicos orgánicos ocultos paralelos (Leucemias/Mielomas).** - **Tratamiento Corticoideo Inversivo Agresivo:** Los bisturíes son letales. Cortan curando con dosis extremas locales untadas de Inmunomodulación de asalto fuerte: **Corticoides Tópicos de extremada superior altísima extrema general de base fuerte de potencia,** o de fallar escalamiento a Sistémicos Corticoides por pastillas orales de choque al cráter inmaculado.

3. Eritema Indurado de Bazin (La Paniculitis Tuberculosa Oculta)

- **Fisiopatología Secundaria Causal Excluyente Analítica Infecciosa:** Corresponde a una reaccionada paniculitis inflamatoria secundaria al bacilo letal latente de la cruzada extrema respiratoria mundial **Microbacterium Tuberculosis (TBC).** - **Cuadro Clínico**

Perimetral Anatómico Físico Revesado: Las lesiones imitan al Eritema Nodoso (nódulos duros color violáceo a rojo), sin embargo encubren la diferencia anatómica patognomónica N°1 basal cruzada limitante a: Se posicionan anatómicamente y en masa en **LA CARA POSTERIOR GEOGRÁFICA LIMITANTE ANATÓMICA EXTERNA GENERAL (Las Pantorrillas / Gemelos traseros) DE LAS PIERNAS.** - **Complicación Cráterica Ulcerosa Perimetral Frecuente:** Estos nódulos se licuan internamente frecuentemente necrosándose y desarrollando úlceras cicatriciales al centro dactilar perimetral de resolución difícil lenta y prolongada cruda general en el asedio. - **Tratamiento Cruzado Integral Sistémico Causal de Oro:** No frenan ni curan remitiendo la mancha reaccionaria con ninguna crema superficial, se debe destruir y limpiar matando biológicamente al nido del microbacilo crudo basal endógeno a perennidad con antibióticos: **Terapia TBC oficial protocolo nacional (Esquema general letal mundial RIPE).**

4. Dermatitis Herpetiforme (La Celíaca dérmica)

- **Fisiopatología Genética Digestiva Asediante Secundaria:** No tiene contacto humano ni genético base ni estructural cruzado remoto alguno con ningún agente reaccionario externo del Letal Virus Herpes. Su nombre recae en su aspecto general engañoso. Su base obedece genéticamente al enteropatismo total crónico mundial atópico a la matriz estomacal inflamatoria celulosa basal de anticuerpos por base patognomónica cruzada reactiva extrema intestinal a la intolerancia de absorción gástrica a la dieta por **Enfermedad Celíaca inmaculada pura a la enzima del crudo proteína del Gluten general.** - **Cuadro Clínico y Frecuencia Topográfica Inmaculada Físico:** Presenta de manera asediante fulminantes brotes maculares pápulares recubiertas de minúsculas **micro Vesículas transparentes o escoriaciones crónicas rotas, INMENSAMENTE PRURIGINOSAS e incontrolablemente desesperantes rancias al rascar cruzadas asiduas al roce** en su aparición estirada general a lo largo en paralela a zonas Extensoras reaccionariamente en los **Codos perimetrales, cruas de Rodillas, muslos anteriores y pliegues cruzados estirables Glúteos y lumbares traseros dorsos cruzados purulentos.** - **Manejo Terapéutico Rescatador Radical Oral Definitivo:** Obliga incondicional a base dietaria vital excluyente cruzada **Restricción total perpetua a Dieta libre limpia Exenta de estipulante Cero tramos orgánicos de base al Gluten Celiaco de harinas.** Adjuntado farmacológicamente de cruce de oro a la droga que limpia cruzada las lesiones letales generales enrojecidas inmediatas rápido recetando la tableta de **Dapsona oral sintética activa cruzada de base.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la diferencia entre el rash malar del lupus y el eritema de la rosácea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Enfermedades Autoinmunes con Imágenes. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El rash en mariposa del lupus sistémico respeta el surco nasogeniano a diferencia de la rosácea.
- El lupus discoide produce cicatriz y alopecia cicatricial permanente en las lesiones.
- Las pápulas de Gottron en los nudillos son prácticamente patognomónicas de dermatomiositis.
- El rash heliotropo es la coloración violácea en párpados superiores de la dermatomiositis.
- El signo del chal en la dermatomiositis produce eritema en hombros y espalda superior.
- El lupus subagudo produce lesiones anulares fotodistribuidas en el tronco.
- La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria autoinmune con manifestaciones cutáneas específicas.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ENFERMEDADES AUTOINMUNES CON IMÁGENES)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la diferencia entre el rash malar del lupus y el eritema de la rosácea?

- A)** El lupus tiene telangiectasias y la rosácea no tiene ningún componente vascular
- B)** El rash del lupus respeta el surco nasogeniano y la rosácea no lo respeta
- C)** La rosácea tiene comedones y el lupus nunca presenta lesiones comedonales
- D)** El lupus afecta solo el puente nasal y la rosácea afecta mejillas y mentón
- E)** La rosácea desencadena con el frío y el lupus desencadena con el sol exclusivamente

PREGUNTA 2

¿Qué lesión cutánea es prácticamente patognomónica de la dermatomiositis?

- A)** El eritema nodoso en cara anterior de piernas con nódulos dolorosos
- B)** Las pápulas de Gottron sobre los nudillos e interfalángicas de la mano
- C)** Las ampollas tensas con signo de Nikolsky negativo en tronco y extremidades
- D)** La placa eritematodescamativa con raspado de Brocq positivo en codos
- E)** Las máculasacrónicas periorbitales y peribucales de contorno bien definido

PREGUNTA 3

¿Qué es el rash heliotropo de la dermatomiositis?

- A)** Un eritema en forma de mariposa en mejillas y puente nasal que respeta el surco
- B)** Una coloración violácea en los párpados superiores que parece una sombra de ojos morada
- C)** Un eritema fotodistribuido en escote y hombros en forma de V
- D)** Unas pápulas eritematosas sobre los nudillos de ambas manos
- E)** Una placa eritematosa en cuero cabelludo que deja cicatriz permanente

RESUMEN: ENFERMEDADES AUTOINMUNES CON IMÁGENES

Esta clase repasa los hallazgos clínicos y cutáneos de tres enfermedades autoinmunes importantes que deben reconocerse visualmente. El lupus eritematoso puede presentarse de varias formas. El lupus discoide produce placas eritematosas fotosensibles en cara y cuero cabelludo que dejan cicatriz y alopecia cicatricial permanente. El lupus subagudo produce lesiones anulares o psoriasiformes en tronco fotodistribuidas. El lupus sistémico en la piel produce el rash en mariposa o eritema malar que afecta ambas mejillas y el puente nasal pero que característicamente respeta el surco nasogeniano, a diferencia de la rosácea. La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria autoinmune con manifestaciones cutáneas características. Las pápulas de Gottron son pápulas eritematosas sobre los nudillos, especialmente el dorso de las articulaciones interfalángicas, que son prácticamente patognomónicas. El rash heliotropo es la coloración violácea en los párpados superiores que parece una sombra de ojos morada. El rash en manto o signo del chal produce eritema en hombros, espalda superior y pecho anterior.